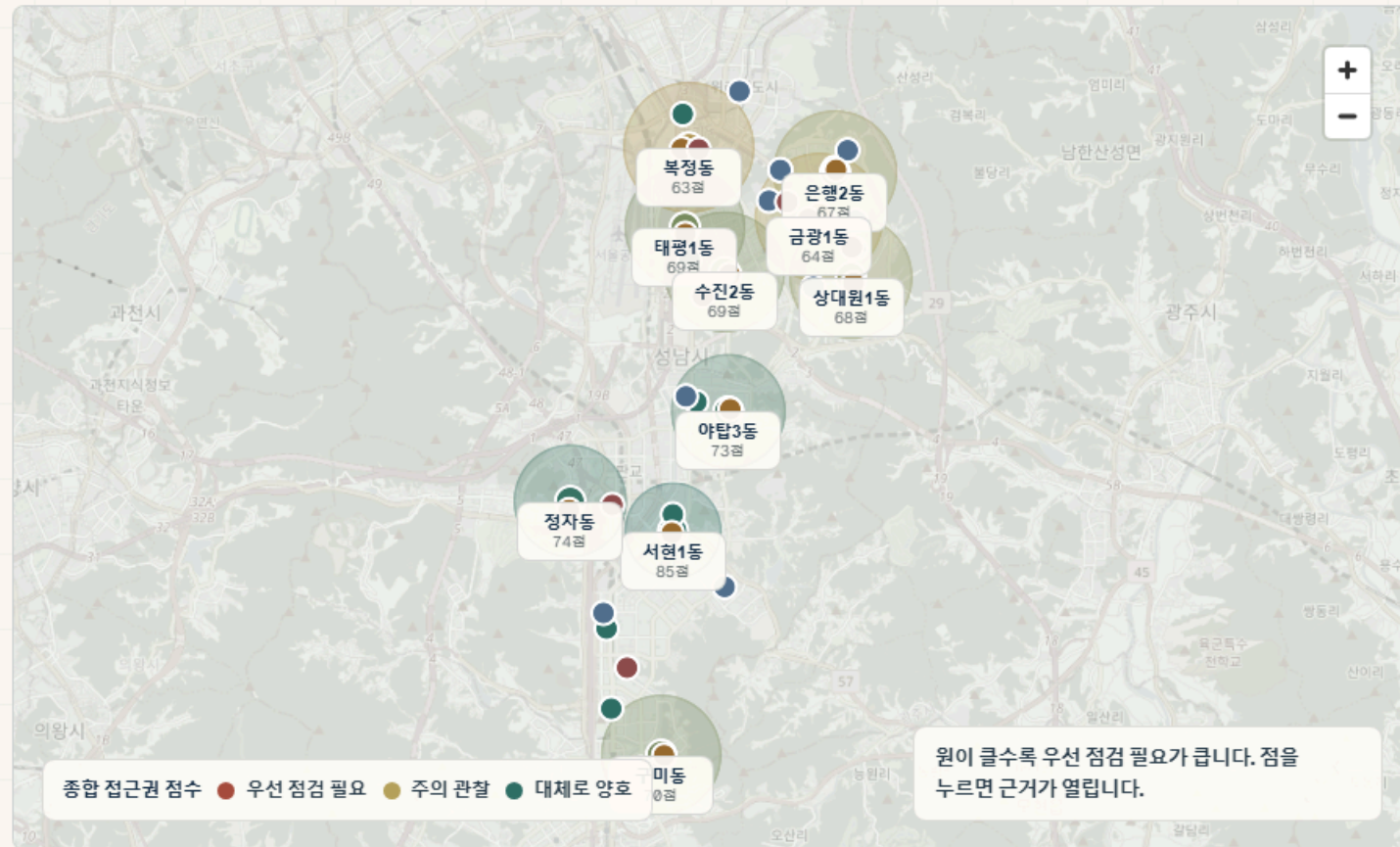


생활서비스가 있는 것과 10분 안에 닿는 것은 다릅니다.

성남의 의료·약국·교통·돌봄 접근성을 대표 생활권 단위로 비교했습니다.

생활서비스의 개수보다 실제 접근성이 정책 우선순위를 가릅니다.



대표 생활권 평균 접근성

70

대표 생활권 평균 접근성은 70점입니다.

점수가 높을수록 생활필수 서비스에 닿기 쉬운 것으로 해석합니다.

우선 확인 생활권

태평1동

1 종합 69점 ·
돌봄 65점

돌봄 접근 보완형

수진2동

2 종합 69점 ·
의료 60점

의료 접근 보완형

은행2동

3 종합 67점 ·
의료 54점

의료 접근 보완형

서비스별 접근성을 나눠 보면 먼저 확인할 지점이 달라집니다.

의료·약국·교통·돌봄별 평균 점수와 우선 확인 생활권을 함께 비교합니다.

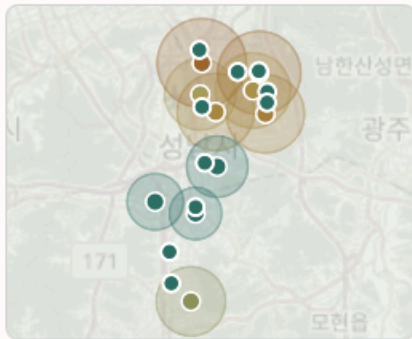
정책적 의미: 같은 생활권이라도 먼저 보완할 서비스는 다를 수 있습니다.

● 우선 점검 ● 주의 관찰 ● 대체로 양호

우선 확인 생활권 TOP 3

+ 의료 접근성

평균 67점



우선 확인 생활권

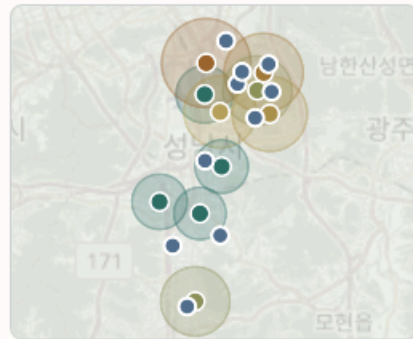
복정동, 은행2동, 상대원1동

동네의원·보건소 연계망을 우선
확인합니다.

우선 확인 생활권 TOP 3

Rx 약국 접근성

평균 71점



우선 확인 생활권

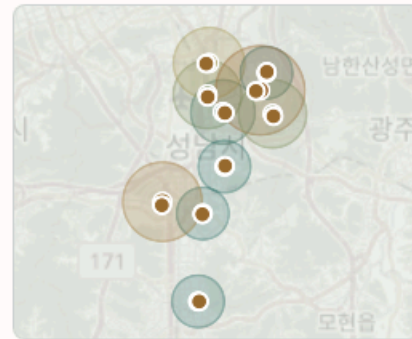
복정동, 은행2동, 상대원1동

공공심야약국 접근성을
점검합니다.

우선 확인 생활권 TOP 3

B 교통 접근성

평균 73점



우선 확인 생활권

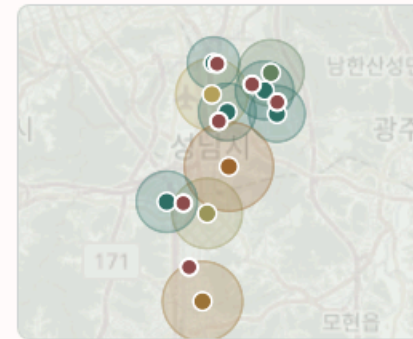
금광1동, 정자동, 복정동

정류장 보행로와 마을버스
배차를 점검합니다.

우선 확인 생활권 TOP 3

C 돌봄 접근성

평균 71점



우선 확인 생활권

야탑3동, 구미동, 태평1동

찾아가는 복지와 임시 거점
운영을 검토합니다.

접근이 어렵고 지원수요가 높은 곳부터 확인합니다.

가로축은 접근 어려움, 세로축은 지원수요입니다.

오른쪽 위에 가까울수록 현장 확인 우선순위가 높습니다.

우선 점검은 예산 투입 확정이 아니라, 현장 확인의 우선순위를 정하기 위한 정책 탐색 결과입니다.



색상은 정책 보완 유형, 원 크기는 인구 규모를 나타냅니다.

데이터 분석 결과를 부서별 정책 보완 방향으로 연결합니다.

의료 접근, 이동 접근, 돌봄 접근, 복합 보완 필요 유형으로 나눴습니다.

단기 점검과 중기 검토 과제를 분리해 실제 부서 협업으로 이어지게 구성했습니다.

정책적 의미: 정책은 순위가 아니라 유형별 보완 방향으로 이어져야 합니다.

가까운 의료·약국 이용을 우선 확인할 생활권

의료 접근 보완형

수진2동

북정동

은행2동

상대원1동

데이터 신호 의료·약국 점수가 낮고 고령·1인가구 비중이 함께 높습니다.

단기 점검 동네의원·약국·야간/휴일 진료 정보를 정리합니다.

중기 검토 공공보건, 방문상담, 복약 안내를 연계합니다.

정류장 접근과 보행 연결을 함께 볼 생활권

이동 접근 보완형

금광1동

정자동

데이터 신호 생활서비스 이동 의존도가 높고 정류장 접근 점수가 낮습니다.

단기 점검 정류장 보행동선, 경사, 횡단 안전을 점검합니다.

중기 검토 마을버스 보완과 생활서비스 연결 노선을 검토합니다.

돌봄 수요와 생활서비스 거점을 맞춰볼 생활권

돌봄 접근 보완형

태평1동

서현1동

야탑3동

구미동

데이터 신호 돌봄 점수가 낮고 고령·돌봄수요가 높은 생활권입니다.

단기 점검 찾아가는 돌봄서비스와 행정복지센터 이용 정보를 정비합니다.

중기 검토 임시 거점, 방문상담, 복지 안내체계를 보완합니다.

여러 생활서비스를 함께 점검할 생활권

복합 보완 필요형

복합 보완 필요 생활권이 없으면 서비스별 우선 점검 카드로
나뉘 검토합니다.

데이터 신호 여러 서비스 점수가 함께 낮거나 지원수요가 높은 생활권은
별도 검토합니다.

단기 점검 의료·교통·복지 부서가 함께 현장을 점검합니다.

중기 검토 복합 생활서비스 거점 또는 통합 안내체계를 검토합니다.